

갑상선 결절, 언제 검사하고 언제 지켜볼까요?



광고바른내과

갑상선 초음파 안내

초음파 모양(K-TIRADS)과 크기 기준으로 필요한 검사만 정확히 고릅니다.

CORE MESSAGE

**결절이 보인다고 모두 세침흡인검사를
하지는 않습니다.**

좋은 모양은 지켜보고, 의심 모양은 기준 크기에서 확인합니다. 검사 뒤에는 Bethesda class에 따라 추적 방향이 달라집니다.

STEP 1

모양

초음파에서 양성
모양인지, 의심 소견이
있는지 봅니다.

STEP 2

크기

등급별 FNA 기준을
넘는지 확인합니다.

STEP 3

결과

Bethesda 결과와
초음파를 합쳐 추적
계획을 정합니다.

K-TIRADS 초음파 모습과 FNA 기준

대표 초음파 예시와 검사 기준을 함께 봅니다



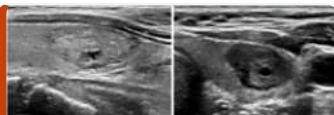
K-TIRADS 2

양성

전형적 양성 모양

해면모양, 순수 낭종, 낭성 부분 안
해성꼬리 인공음영.

FNA: 일반적으로 안 함



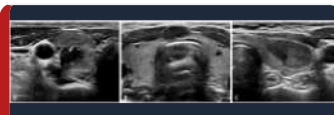
K-TIRADS 3

낮은의심

작으면 추적 우선

부분 낭성 또는 등/고에코 결절이며 3대
의심소견이 없음.

FNA: > 2.0 cm



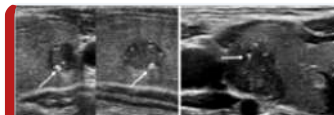
K-TIRADS 4

중간의심

정밀 확인 후보

의심소견 없는 저에코 고형결절,
의심소견 동반 등/고에코, 완전 석회화.

FNA: > 1.0~1.5 cm



K-TIRADS 5

높은의심

놓치면 안 되는 군

저에코 고형결절에 점상 고에코, 세로로
긴 모양, 불규칙 경계 중 하나.

FNA: > 1.0 cm

크기 기준 — 검사할 결절을 고르는 법

- K2** 임상적 FNA 없음. 커져서 치료 계획이 필요하거나 절제술 전 확인이 필요하면 예외.
- K3** 2 cm 초과부터 FNA 고려. 작고 안정적이면 추적 위주.
- K4** 1~1.5 cm 초과. 위치, 초음파 소견, 임상 위험인자, 선호도에 따라 결정.
- K5** 1 cm 초과부터 FNA. 림프절 전이, 명백한 외부 침범 등은 크기와 무관.

Suspicious features — 의심 신호

점상 고에코

미세석회화처럼 보이는 작은 밝은 점.
고형 저에코 결절 안에 있으면 더
경계합니다.

세로로 긴 모양

taller-than-wide. 옆보다 앞뒤로 더
깊게 자라는 형태입니다.

불규칙 경계

빼죽하거나 미세엽상 경계. 주변으로
파고드는 듯하면 의심도가 올라갑니다.

임상 고위험

의심 림프절, 명백한 외부 침범, 원격
전이, 수질암 의심은 크기 기준보다
우선합니다.

세침흡인검사 결과: Bethesda class별 다음 단계

결과지만 보지 말고, 초음파 위험도와 같이 봅니다

Class	결과	성인 암위험	이후 관리 흐름
I	비진단	약 13%	초음파 유도 재검. 반복 비진단·성장·강한 의심이면 CNB 또는 진단적 수술 고려.
II	양성	약 4%	즉시 치료는 보통 불필요. K5 모양은 6~12개월, K3/4는 12~24개월 후 재평가.
III	AUS	약 22%	재FNA, CNB, 분자검사, 추적 또는 진단적 수술 중 선택.
IV	여포종양	약 30%	진단적 엽절제술을 주로 고려. 분자검사 결과에 따라 선택적 추적 가능.
V-VI	악성 의심/악성	약 74~97%	수술 평가가 기본. 성인 저위험 미세유두암은 조건이 맞으면 적극적 관찰도 논의.

오늘 가져갈 한 줄

결절 발견은 출발점입니다. 좋은 모양은 지켜보고, 의심 모양은 기준 크기에서 확인합니다.
의미 있는 성장 또는 새 의심소견이 생기면 판정을 업데이트합니다.

기준일: 2026-05-13. 근거: 2021 K-TIRADS consensus, 2023/2024 대한갑상선학회
갑상선결절 진료권고안, 2023 Bethesda System. 초음파 예시 이미지: Ha EJ et al., **Korean
J Radiol.** 2021, CC BY-NC 4.0.

